

尿动力学检查报告（中文翻译）

悉尼尿动力学中心（Sydney Urodynamic Centres）· 报告日期：2025年10月8日 · 致转诊全科医生 Dr L Guan

【非官方翻译，仅供参考 —— 英文原件随附。翻译日期：2026-08-31。】患者：Yujie Cao, 1997年8月8日出生。

转诊背景与病史（报告原文意译）

感谢转诊这位28岁女性行尿动力学评估。她的膀胱问题**病史长，可追溯至童年**。主要困扰为尿频、尿急，且**多数日子有急迫性尿失禁**；偶有压力性尿失禁。已影响生活质量。曾接受盆底物理治疗及TENS（经皮神经电刺激）治疗，效果不佳。

总体健康，未生育。无特殊月经问题。她可能自行减少饮水量，这或为其便秘的一个因素。

查体：体重正常；腹部触诊无异常；盆腔评估无明显脱垂、无肿块或压痛；子宫后位。

检查结果

- 尿流率测定（Uroflowmetry）**：峰值尿流率仅 **12 ml/s**，排尿模式呈**间断型**。初始残余尿 60 ml，**检查结束时残余尿 300 ml** —— 提示可能存在排尿功能障碍。注：患者当天有肠道不适（腹泻），可能抑制了排尿。
- 动态尿道镜检查（Dynamic urethroscopy）**：尿道及膀胱未见异常；无息肉、结石或间质性膀胱炎证据。尿道闭合压正常（63 cmH₂ O）。
- 膀胱测压（Cystometrogram）**：初始尿意出现于 100 ml；**膀胱容量仅 300 ml**；出现**多次异常逼尿肌过度活动（detrusor overactivity）**，其中一次伴漏尿。

结论（报告原文意译）

存在**显著的逼尿肌过度活动**。当天未能诱发出压力性尿失禁。**可能存在排尿功能障碍成分，需要监测**。已与患者讨论：建议完成排尿日记、减少咖啡因摄入；提示进行膀胱再训练及盆底锻炼；建议试用**米拉贝隆（Betmiga）50 mg 每日一次**并已开具处方。**需要监测残余尿**。

补充说明（患者方注，非报告内容）

- 米拉贝隆处方后**从未服用**（2026-08-19确认）。
- 2026-08-18 MRI 确诊脊髓栓系（马尾脂肪瘤）后回读本报告：逼尿肌过度活动 + 小容量（300 ml） + 大量残余尿（300 ml） = **与脊髓栓系一致的神经源性膀胱模式**，为MRI之前即已存在的骶髓受累客观证据。